



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مجدي الجوهري سليمان الجوهري

العنوان : 0

الحي / المدينة : السيده زينب

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 26002271602333 رقم التليفون : 01112217745

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-02-1960 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان الرئة

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان الرئة

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [6352] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع : (-----)

الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع : (-----)

الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع : (-----)

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : ----- قسم : -----

جهة العلاج : ----- نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مجدي الجوهري سليمان الجوهري National ID: 26002271602333	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of lung cancer for Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مجدى
الجوهري سليمان الجوهري
٣٥ مساكن زينهم
السيدة زينب - القاهرة

١٩٦٠/٠٧/١٧

٢٦٠٠٢٢٧١٦٠٢٣٣٣

LW1216599





Date Of Submission:

Date Of MDT:

09/23/2026 09:36:46

Medical Report

Patient Name :

مجدى الجوهري سليمان الجوهري

Age :

67 Y

Sex :

☐ Male ☐ Female

Comorbidity :

26002271602333

ID No. :

12555

Telephone :

Family History :

Marital Status :

☐ Married ☐ Divorced ☐ Single

Menopausal Status :

Reason of MDT :

MDT name::

Medical Report

Diagnosis :

right lung paratracheal mass

Notes :

History:

smoker , haemoptysis

Investigations:

Ct guided biospy is not feasible, for bronchoscopic biopsy

Bone Scan: Diffuse inhomogenous skeletal uptake (likely reactive)

CT CAP: Rt upper Lung lobe hilar / paratracheal mass lesion 8 * 6 cm + few mediastinal LN + Bilateral sacral-proximal femoral small sclerotic foci.

Recommendations:

VATS biopsy

MDT DECISION:

VATS biopsy

Specialty

Surgery

Pathology

Radiology

TRANSTHORATHIC ECHOCARDIOGRAPHIC REPORT

Name : Magdy El Gohary Soliman
Referring physician Prof Dr/
Clinical Diagnosis:

Age Y Date : July 8, 2026
Ref No:

MEASUREMENTS:

LVED:	4.4	(3.5 – 5.9)cm	LA:	3.4	(1.9 - 4.0) cm
LVES:	2.8		Ao:	2.8	(2.0 – 3.7) cm
SWT:	1.1	(0.7 -1.1)cm	RV:		(1.6 - 2.6) cm
PWT:	1.1	(0.7 – 1.1)cm	MVA:		Cm ²
FS%:	35%	(25 – 45%)	EF:	65%	

COLOUR CODED DOPPLER STUDY

	Maximum Velocities	Peak	Mean	
Aortic:	m/sec			mmHg
Pulmonary	m/sec			mmHg

Chambers:

- * **Left ventricle:** Normal LV internal dimensions , wall thickness and overall systolic function. No segmental wall motion abnormalities at rest.
- * **Left atrium:** normal.
- * **Right side chambers:** Normal.
- * **RVOT and LVOT:** Normal.
- * **Interatrial septum and Interventricular septum:** Intact by TTE.

Valves:

- * **Mitral valve:** Normal thickness and excursion. Trivial mitral regurge, no stenosis. Mitral Doppler flow shows normal E/A ratio.
- * **Aortic valve:** Trileaflet mildly thickened valve with normal excursion. Trivial aortic regurge, no stenosis.
- * **Tricuspid and pulmonary valves:** Normal thickness and excursion. Trivial tricuspid regurge , estimated PASP=29mmHg, no stenosis.

Great vessels: Normal.

Intracardiac masses or thrombi: one by TTE.

Pericardium:

- * Normal thickness. No pericardial effusion.

Conclusion:-

- * Normal trans-thoracic echocardiographic study apart from mild aortic valve disease.

Best Regards
Dr. Mohamed Omar
MD Cardiology

Name: Magdy El Gohrey Soliman

Prof. Dr: Ahmed Abd-Alkader Namr

Date: 9/7/2026

Code: 47541

1- MRI Examination Of The Brain

Technique of examination:

- Axial T1, T2 and FLAIR WI's
- Sagittal T1 WI's
- Diffusion study
- Post contrast study

Findings

- Left frontal subcortical 2X1.8cm intra-axial lesion with surrounding vasogenic edema and related mass effect. The lesions eliciting low T1, high T2 and irregular marginal enhancement with focus of peripheral diffusion restriction.
- Another smaller similar lesion seen at medial aspect of left cerebellar hemisphere. 1.3x1.1cm.
- Left frontal periventricular small area of old infarction as well as bilateral frontal white matter chronic ischemic foci.
- No acute ischemic insult in diffusion study
- Prominent ventricles and cortical sulci
- No midline shift
- No intra or extra axial areas of fresh blood signal or its degradation products
- The suprasellar cistern is clear.

2- MRA Examination of the Neck

Technique:-

- 3D TOF MRA of the neck arteries

Findings:-

- Patent normal caliber carotid arteries as well as internal and external carotid arteries on both sides.
- Normal MRA appearance of the vertebral arteries on both sides
- No evidence of stenotic segments, vessel occlusion or vascular malformation.
- Scanned upper chest cuts show right upper lung lobe central mass lesion 8.2x4.7 cm, likely neoplastic for CT correlation.

Opinion:

- *Left cerebral and cerebellar SOLs, likely metastatic.*
- *Right upper lung lobe mass lesion. Likely primary neoplasm for CT scan.*
- *Normal neck MRA study.*

Best Regards;
Dr. Moustafa El Shafei, MD

<u>NAME:</u>	Magdy AlGohary
<u>DATE:</u>	8 July 2026

Duplex study of both extra-cranial carotid and vertebral systems

- Bilateral diffuse intima-media complex thickening of examined carotid arteries bilaterally. On the right side reaches 1.1mm and in the left side 1.2mm.
- Left carotid bulb eccentric calcific atheroma about 15 mm extending to beginning of ICA causing about 31 % diameter stenosis.
- No sizeable right side atheromatous plaques seen.
- Normal caliber, antigrade flow of both vertebral arteries with average indices along their course,

Right vertebral artery RI = 0.68

Left vertebral artery RI = 0.67

Conclusion

- *Bilateral mild carotid diffuse atherosclerotic changes with left carotid bulb haemodynamically insignificant atheroma as described.*

Best Regards.

Dr. Mohammed Ramadan , M.Sc